

Domaines Dopaminergiques

Voies Dopaminergiques = Fascicule Dopaminergique

Voies Mésolimbiques (ATV: Axi Tegmental Ventral)

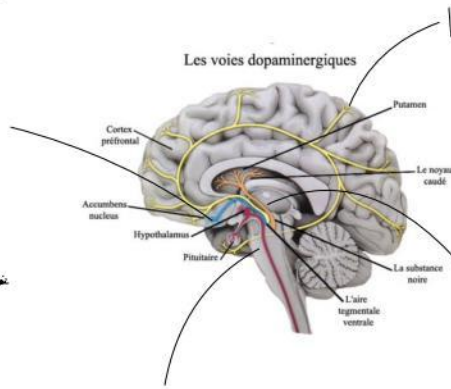
• plaisir / Motricité / Récompense

• Dépression

Hypométrie = Hallucination / Délire

Hypométrie = Perte motivation

Sp. Positif
Schizophrénie



Voies Mésocorticales (Axi Tegmental Ventral → Cortex)

• Mémoire à court terme

• Régulation des émotions

Hypométrie = isolé / replié sur soi

Sp. Négatif
Schizophrénie

Hypométrie = hyperphobie / anxiété

5HT-2A excitation → Neuron GABA → I' ≠ Dopamine

T. Antipsychotique → P. Dopamine

Voies Nigrostriales (Substance Noire → Striatum)

• Mémoire à court terme / mouvement (circuit Extrapyramidal)

Hypodopaminergie: Syndrome Extrapyramidal

- Akathisie: besoin incessant de bouger
- Tremblement (distal; augmenté à l'arrêt)
- Hypométrie: Rigidité (à l'arrêt)

Traitement Pharmacologique

5HT-2A → Neuron GABA → I' ≠ dopamine

Voies Tuberohypophysoires (Hypothalamus → Axi Tegmental Ventral)

Dopamine → I' Sécrétion Prolactine

Hypodopaminergie = Prolactinémie (douleur thoracique) + VLDL

S. Positif: Confort (Hallucination)

Schizophrénie

+ S. négatif

S. Négatif: Dépression (Hypométrie)

Neuroleptique 1^{er} Génération:

Antid. D2

Mésolimbique = Hallucination (Comp. & S. Positif)

Mésocortical = ↑ dopamine (S. Négatif)

Nigrostriale = ↑ S. Extrapyramidal (Parkinsonisme)

Tuberohypophyse = ↑ Prolactine

Récepteurs (sensibilisés):

I° M1 - S. Anticholinergique

I° α1/Adre = Hypotension

I° H1 = Somnolence à prise de poids

I° canal HERG = Risque Torsades de pointes

Neuroleptique 2^{ème} Génération ("Atypique"):

CLONAZEPINE

Antagoniste D2

Antagoniste 5-HT2A

↓ S. Positif

↓ S. Négatif (compensé par l'activation des neurones GABA)

MAIS il y a des problèmes périphériques

QT long → fibrillation ventriculaire → Arrêt ⚡

- QT long

Caution: Risque d'arrêt cardiaque

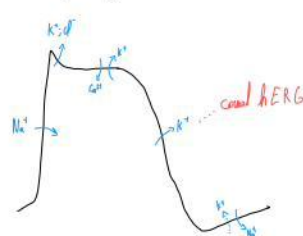
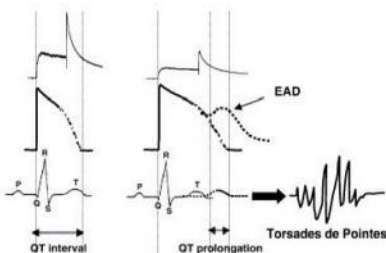
Normal conditions

HERG block

HERG channel (I_{Kr})

Action potential

ECG



1Dp

Reception D1-like (D_1, D_5 = Excitation)

RCPG-20



$(SNC) = \uparrow PA; \uparrow \text{diphenol}$

Griff. u. Verschlüsselung

W₂ Rein Naturisolege = Hygrotherm

✓ No Absorbent Infection

D2-lib ($D_2, D_3, D_4 = \text{Inhibition}$)

RCPG-2:

AC✓

(SNC) ^{post} Hypophyseintum (PPI) = ↓ Bildung ACh an post-ganglion

$$R^G = \bigvee G^{2^k} = \bigvee \text{Libertine NT}$$

③ Σ = 1 libération NorAdri = Hypertension orthostatique — (E) Agente Dopamine

Entonces $\rightarrow$ ACA

Antidysplasia = ↓ Proliferation

Area POSTREMA = contor normal (nu putaj PHE) = 7 pt diferite

Agonists Directs No Sleep.

+ ← Dopamin (mas Subst. D1, D2) → +

Ne pas per VHE $\rightarrow$ DOPA injectés

Faktor Dua = Aktivitas dan Aktivitasnya

$$D1 \rightarrow \beta 1 \downarrow \rightarrow \beta 1 \downarrow$$

+ ← Apomorphies → +

Apomorphine

Non-salicyl + Low DHE + EGT analysis

4-6 Bromocyclopentadiene $\xrightarrow{\text{D}_2}$

Bromocriptin D2

Moléculas derivadas epódo singlo (massa 5 HT)

Robinia D2 & D3

$= 2^{\text{nd}}$ Conductor

Treatment Maladie Parkinson = Prélèvement Matrice Sphérique Nigro Striata

- *Hydrophobus*

- Juntos com rapas

① Hypotensive substances + Trunkles Psychiatric / Medication

L-DOPA (Levodopa)

Par le DHE nous s'agit

DOPA $\rightarrow$ dopamine $\xrightarrow{\text{CARBI DOPA (I' DOPA analog)}}$

COMT — ENTACAPONE

MAO $\rightarrow$ IMAO (SÉLÉGILINE)

Antikörper des Depressionsgen Drd10 → Neuroleptikresistenz Anti D2 ⚠ Symptom nach Neuroleptika = Hyperthermie + tremor + Schweiß → Antidot URSEIT

offensive and defensive

22.

Polypharmacie = > 5 médicaments → Risque Interactions

Interactions Risque = Avant d'analyser le Symptôme, on demande "est-ce l'effet d'un médicament ?"